

Évaluation objectif 39: HYPERTHYROÏDIE

Pr Fatma MNIF BOUSSARSAR

Pr Ag Dhoha BEN SALAH KAMMOUN

1/ Une hyperthyroïdie peut être secondaire à :

- A. Une inflammation de la thyroïde d'origine virale
- B. Une administration d'iode radioactif
- C. Une hyperstimulation par HCG
- D. Une hyperstimulation par GH-RH
- E. Une ectopie thyroïdienne

2/ Une hyperthyroïdie peut être secondaire à :

- A. Un nodule thyroïdien froid
- B. Une thyroïdite de Hashimoto
- C. Un tératome ovarien contenant du tissu thyroïdien
- D. Une prise factice d'hormones thyroïdiennes
- E. Une radiothérapie hypophysaire

3/ Les médicaments susceptibles d'engendrer une hyperthyroïdie sont :

- A. Le Lithium
- B. Les hormones thyroïdiennes
- C. Les corticoïdes
- D. Le phénobarbital
- E. L'Interféron

4/ Concernant l'hyperthyroïdie par surcharge iodée de type 1:

- A. Est plus fréquente dans les zones d'apports iodés faibles
- B. Une pathologie thyroïdienne sous-jacente est présente
- C. La scintigraphie thyroïdienne est blanche
- D. L'échographie est sans anomalies
- E. Est liée à l'effet toxique de l'iode sur les thyrocytes

5/ Concernant l'hyperthyroïdie par surcharge iodée de type 2 :

- A. Est plus fréquent dans les zones d'apports iodés élevés
- B. La thyroïde est d'aspect clinique normal
- C. La scintigraphie thyroïdienne est blanche
- D. L'échographie montre une glande hypoéchogène et homogène
- E. Est liée à l'augmentation de la synthèse et la sécrétion d'hormones thyroïdiennes

6/ La surcharge iodée peut être responsable de :

- A. Une hyperthyroïdie par le phénomène de Wolff-Chaikoff
- B. Une hypothyroïdie par défaut d'échappement au phénomène de Wolff-Chaikoff
- C. Une hyperthyroïdie par hyperfonctionnement thyroïdien sur une glande thyroïde préalablement dystrophique
- D. Une hyperthyroïdie par mécanisme lésionnel sur une glande thyroïde préalablement saine
- E. Une hypothyroïdie par infiltration lymphocytaire

7/ Une hyperthyroïdie peut être responsable de :

- A. Une augmentation de la consommation d'oxygène
- B. Une hypersensibilité au système nerveux sympathique
- C. Une vasoconstriction
- D. Une hyper filtration glomérulaire
- E. Une stimulation de la lipolyse et de la lipogenèse au profit de la lipogenèse

8/ Une thyrotoxicose est évoquée devant :

- A. Un teint caroténoïde
- B. Un amaigrissement associé à une anorexie
- C. Une rétraction de la paupière supérieure
- D. Un syndrome du canal carpien
- E. Une diminution de la force musculaire

9/ Parmi les manifestations cliniques d'une hyperthyroïdie en dehors des complications :

- A. Une fibrillation auriculaire
- B. Un syndrome polyuro-polydipsique discret
- C. Une Insuffisance cardiaque à prédominance droite
- D. Un accès maniaque
- E. Gynécomastie chez l'homme

10/ Une Hyperthyroïdie peut être évoquée devant:

- A. Un élargissement de la pression artérielle différentielle
- B. Une pseudo-hypertrophie musculaire
- C. Un signe du tabouret positif
- D. Un prurit généralisé
- E. Des paresthésies des extrémités

11/ Le syndrome de thyrotoxicose comporte :

- A. Une diarrhée motrice
- B. Une exophtalmie bilatérale
- C. Une nervosité excessive
- D. Un myxœdème pré tibial
- E. Des réflexes ostéotendineux vifs

12/ Le bilan biologique au cours d'une hyperthyroïdie peut montrer :

- A. Une anémie microcytaire
- B. Une hypercholestérolémie
- C. Une leuco-neutropénie
- D. Une hypercalcémie
- E. Une hyponatrémie

13/ Parmi les perturbations non spécifiques pouvant révéler une hyperthyroïdie :

- A. Une élévation des phosphatases alcalines
- B. Une hyperleucocytose
- C. Une hyperglycémie
- D. Une Hypertriglycéridémie
- E. Une élévation des enzymes musculaires

14/ Le bilan demandé de première intention devant une suspicion d'une hyperthyroïdie est:

- A. FT4
- B. TSH
- C. FT4-TSH
- D. FT3
- E. Thyroglobuline

15/ Une baisse de la TSH peut être constatée indépendamment de toute maladie thyroïdienne :

- A. Chez les patients en mauvais état général
- B. Lors du troisième trimestre de la grossesse
- C. Chez les patients traités par analogues de la somatostatine
- D. Lors d'une corticothérapie prolongée
- E. Lors d'un traitement par diurétique

16/ Une baisse de la TSH isolée avec FT4 normale peut être constatée :

- A. Chez les patients traités par dopaminergiques
- B. En cas d'hyperthyroïdie sub-clinique
- C. En cas d'hypothyroïdie centrale
- D. En cas d'hyperthyroïdie centrale
- E. Chez les patients hospitalisés en unité de soins intensifs

17/ Parmi les complications de l'hyperthyroïdie, on peut citer :

- A. Bloc auriculoventriculaire
- B. Décompensation d'une insuffisance coronaire
- C. Syndrome cérébelleux
- D. Paralysie périodique thyrotoxique hypokaliémique
- E. Ostéoporose

18/ Une hyperthyroïdie non traitée peut se compliquer de :

- A. Insuffisance cardiaque avec débit cardiaque altéré
- B. Crise aigüe thyrotoxique
- C. Délire
- D. Syndrome d'apnées du sommeil
- E. Fracture osseuse

19/ La Crise aigüe thyrotoxique :

- A. Est d'installation insidieuse
- B. Peut survenir à tout âge
- C. Peut mettre en jeu le pronostic vital
- D. Peut se voir après thyroïdectomie
- E. Peut être déclenchée par la mise sous antithyroïdiens

20/ Une crise aigüe thyrotoxique peut être déclenchée par :

- A. Le froid
- B. L'arrêt du traitement antithyroïdien
- C. La prise d'amiodarone
- D. Une angio-TDM des artères rénales
- E. La prise de tranquillisants

21/ Une crise aigüe thyrotoxique peut être déclenchée par :

- A. Cholécystectomie
- B. Traitement par iode radioactif
- C. Prise de bêtabloquants
- D. Infarctus de myocarde
- E. Infection respiratoire

22/ Une crise aigüe thyrotoxique se traduit par:

- A. Hyperthermie majeure
- B. Déshydratation
- C. Une hyponatrémie sévère (< 120 mmol/l)
- D. Vomissements
- E. Hypercapnie

23/ Devant une hyperthyroïdie, les signes en faveur de la maladie de Basedow sont :

- A. Le caractère homogène du goitre
- B. Le caractère ferme du goitre
- C. La présence d'un œdème palpébral
- D. La présence d'une rétraction de la paupière supérieure
- E. La présence d'anticorps anti récepteurs de la TSH de type stimulant

24/ Les éléments qui évoquent une maladie de Basedow devant une hyperthyroïdie sont :

- A. Le caractère douloureux du goitre
- B. Le caractère hypervasculaire du goitre
- C. Le sexe féminin
- D. Asynergie oculo-palpébrale
- E. La présence d'un myxœdème prétilial

25/ Au cours de la maladie de Basedow l'exophtalmie:

- A. Est spécifique de la maladie
- B. Est constante
- C. Est sans relation avec le degré de thyrotoxicose
- D. Est corrélée au taux des anticorps anti-récepteurs de la TSH
- E. Peut précéder la thyrotoxicose

26/ Lors de la maladie de Basedow, l'exophtalmie peut être aggravée par :

- A. Le tabac
- B. L'iode radioactif
- C. L'arrêt des antithyroïdiens
- D. Une corticothérapie
- E. Un passage rapide en hypothyroïdie

27/ Concernant l'ophtalmopathie Basedowienne:

- A. Est souvent symétrique
- B. Est irréductible
- C. Relève d'un mécanisme auto-immun
- D. Peut être responsable d'une paralysie complète d'un muscle oculomoteur
- E. Peut se manifester par une photophobie

28/ Une scintigraphie thyroïdienne est indiquée en cas de :

- A. Exophtalmie avec TSH freinée
- B. Goitre homogène avec TSH élevée
- C. Nodule thyroïdien avec TSH freinée
- D. Goitre avec TSH normale
- E. Traitement par amiodarone avec TSH freinée

29/ Une hyperthyroïdie associée à une scintigraphie blanche peut se voir en cas de :

- A. Surcharge iodée
- B. Maladie de basedow
- C. Thyroïdite subaigüe de De-Quervain
- D. Prise factice d'hormones thyroïdiennes
- E. Hashitoxicose

30/ Devant une hyperthyroïdie, les éléments en faveur d'un adénome toxique :

- A. Anticorps antithyroïdiens négatifs
- B. Nodule thyroïdien douloureux à la palpation
- C. Nodule extinctif à la Scintigraphie thyroïdienne
- D. Thyroglobuline élevée
- E. Vitesse de sédimentation augmentée

31/ En cas d'hyperthyroïdie, vous confirmez le diagnostic de goitre multi nodulaire toxique devant :

- A. Hyperthyroïdie déclenchée par un apport massif d'iode
- B. Absence d'exophtalmie
- C. Plusieurs nodules chauds à la Scintigraphie thyroïdienne
- D. Goitre multinodulaire à l'examen clinique
- E. Goitre hyper vascularisé au doppler

32/ Devant une hyperthyroïdie récente chez une adolescente, vous suspectez une thyrotoxicose factice devant :

- A. TSH élevée
- B. FT4 basse
- C. Goitre douloureux
- D. Une thyroglobuline basse
- E. Une scintigraphie thyroïdienne blanche

33/ Une hyperthyroïdie peut être secondaire à la prise de :

- A. Lithium
- B. Inhibiteurs de tyrosine kinase
- C. Interleukine 2
- D. Analogues de la somatostatine
- E. Corticoïdes

34/ Le traitement de la thyroïdite subaiguë de De Quervain, en phase d'hyperthyroïdie dans sa forme modérée repose sur :

- A. Bétabloquants
- B. Antithyroïdiens de synthèse
- C. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
- D. Corticothérapie 1mg/kg
- E. Iode radioactif

35/ Le Carbimazole est un Antithyroïdien de synthèse qui expose aux effets indésirables suivants :

- A. Insuffisance rénale
- B. Agranulocytose
- C. Prurit et rash cutané
- D. Cytolyse hépatique
- E. Rhabdomyolyse

36/ Le traitement chirurgical est indiqué en cas d'hyperthyroïdie dans ces cas :

- A. Goitre compressif
- B. Sujets âgés
- C. Nodule suspect
- D. Premier trimestre de grossesse
- E. Hyperthyroïdie résistante avec ophtalmopathie sévère

37/ Le traitement des hyperthyroïdies par I 131 est indiqué :

- A. Sujet âgé
- B. Crise aigüe thyrotoxique
- C. Thyroïdite subaiguë de De Quervain
- D. Ophtalmopathie sévère
- E. Goitre volumineux

38/ Pour le traitement des hyperthyroïdies, l'administration d'iode 131 est formellement contre-indiquée :

- A. Nodule thyroïdien toxique
- B. Femme enceinte
- C. Allaitement
- D. Orbitopathie basedowienne maligne
- E. Sujet jeune

39/ L'examen indispensable pour surveiller la bonne tolérance d'un antithyroïdien de synthèse est

- A. Hémogramme
- B. Glycémie
- C. Calcémie
- D. Uricémie
- E. Créatininémie

40/ Les situations nécessitant une hospitalisation au cours d'une hyperthyroïdie sont:

- A. Une crise aigüe thyrotoxique
- B. Neuropathie optique par compression du nerf optique
- C. Une insuffisance cardiaque
- D. Âge > 65 ans
- E. Maladie de Basedow évolutive chez une femme enceinte